

31 - 02-Facteurs de risque cardiovasculaires - Pr. L. Bendriss

Alors bonjour, donc on va essayer de se focaliser dans ce cours sur les facteurs de risque cardio-vasculaire et les antécédents et avant ceci, donc le plan qu'on va adopter le long de cette sémiologie cardio-vasculaire est le suivant. Donc A, c'est savoir interroger, donc c'est l'interrogatoire et poser des questions aux patients. Donc on va essayer tout d'abord de voir ou de rechercher les facteurs de risque cardio-vasculaire et puis les antécédents que le patient a présentés antérieurement, puis les signes fonctionnels principaux en cardiologie, à savoir la dyspnée, la douleur thoracique, les pertes de connaissances et les palpitations.

Deuxième chapitre, c'est savoir examiner notre patient et dans cet examen, on commence toujours par un examen qui est global et général, apprécier le patient en globalité, puis on passera à la mesure de notre pression artérielle, qu'elle soit en position debout ou couchée et bien évidemment dans les deux bras, que ce soit le membre supérieur droit et le membre supérieur gauche. Puis dans notre examen, donc on va aussi commencer par l'examen du précordium, qui est la projection un petit peu du cœur à la surface du corps, et bien évidemment c'est l'inspection, la palpation, on saute la percussion et l'auscultation est un tour capital en cardiologie avec un bon stéthoscope. Puis on finit notre examen par un examen vasculaire, que ce soit sur les versants artériels ou sur les veines, et bien évidemment on finit notre examen avec tout l'organisme.

Puis troisième chapitre, c'est les examens complémentaires en cardiologie, nous avons plusieurs examens complémentaires et on va traiter de l'électrocardiogramme, qui est le tracé électrique et la radiographie thoracique, qui va nous visualiser la silhouette cardiaque et la circulation pulmonaire. Pour les autres, on ne va pas les traiter. Alors la première partie, ça va être dédié à l'interrogatoire et l'examen physique.

Sur l'interrogatoire, je rappelle, c'est les facteurs de risque cardiovasculaires, les antécédents et les signes cardinaux. L'examen physique, c'est l'examen général, l'examen cardiovasculaire avec tous ses temps et la mesure de la pression artérielle. Savoir interroger, c'est savoir recueillir les symptômes que vous rapportent le patient, c'est ce qu'on appelle les signes fonctionnels, et cette étape s'appelle l'anamnèse ou l'interrogatoire.

Alors, dans cet interrogatoire, vous avez pratiquement cinq étapes. Relevez d'abord l'identité du patient, nom, prénom, l'âge, situation familiale, marié, divorcé, père de 4 ou 5 enfants. Précisez le motif de la consultation à partir des 4 signes cardiaques dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc douleur thoracique, palpitations, perte de connaissance au display, puis recherchez par la suite les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on va essayer de traiter dans ce cours, recherchez les antécédents qu'elles soient personnelles et familiaux, et un petit peu rentrez dans l'histoire de la maladie en essayant de caractériser le symptôme fonctionnel avec toutes les caractéristiques sémiologiques et puis les signes qui vont s'y associer pour pouvoir s'orienter vers une étiologie.

Alors, par rapport au motif de consultation, vous choisissez donc le symptôme le plus prééminent, soit la douleur, la palpitation ou la perte de connaissance, et à partir de ce symptôme vous allez fouiller dans les antécédents par rapport aux choses qui peuvent se rattacher à ce symptôme, tout ceci pour guider notre raisonnement clé qui va commencer à partir de ceci. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire, alors un facteur de risque cardiovasculaire comme les phénomènes, c'est toute anomalie ou tout simplement une habitude qui va s'associer à un surcroît ou une augmentation de risque de développer une maladie. Alors, des caractéristiques qui sont fondamentales pour le définir, la causalité, donc la relation de cause à effet et non pas une simple association statistique ou hasardeuse, et puis le fondé de cette association va se baser sur l'expansion anatomique ou la présence de complications clés.

Alors, les critères de causalité sont en nombre de 5, la chronologie d'abord où ce facteur de risque doit précéder obligatoirement la maladie pour pouvoir être un facteur prédisposant à développer cette maladie, relation dose à effet, c'est-à-dire que le risque d'avoir une maladie va augmenter quand le niveau du facteur ou son importance augmente et inversement, l'universalité, c'est une association qui va être retrouvée dans toutes les populations quelles que soient l'ethnique ou la race, et puis la plausibilité, c'est que cette association va avoir un fondé sur les hypothèses physiopathologiques et enfin, la liaison entre le facteur et la maladie doit être forte, quantitative, dépendant du statistique, indépendant de tout autre facteur et surtout réversible si vous corrigez votre facteur. Alors, quels sont les facteurs de risque cardiovasculaires athéromateux? Quand je dis athéromateux, c'est un petit peu les facteurs de risque qui vont prédisposer à la formation de plaques d'athérome sur le versant artériel, et une plaque d'athérome est formée d'un noyau lipidique avec des LDL oxydés qui est recouvert de chape fibreuse. Ces plaques d'athérome, quand elles progressent dans le temps en matière de volume, elles peuvent causer ce qu'on appelle des sténoses, des subocclusions ou des occlusions, l'occlusion étant la fermeture complète de l'artère.

Tout ceci pourrait compromettre l'irrigation de l'organe navale et causer une ischémie. Alors, les principales localisations de cette maladie athérosclérose, je vais citer les trois. Les artères coronaires, vous aurez la cardiopathie ischémique, les vaisseaux du cou, à savoir les carotides et le système vertébral, vous aurez les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Et puis, la horte et les artères de l'enfance inférieure, et vous aurez l'artéropathie ou gluteal de l'enfance inférieure. Alors, ces facteurs de risque sont les suivants, hypertension artérielle, quand vous avez un chiffre de pression artérielle supérieure à 140 sur 90 mmHg, l'âge pour une femme au-delà de 60 ans et pour l'homme au-delà de la cinquantaine, un tabagisme, une dyslipidémie avec un LDL cholestérol qui est le mauvais cholestérol au-delà de 1,60, un HDL cholestérol moins de 0,40 g chez l'homme et moins de 0,50 chez la femme, et volonté encore plus, une hypertriglycémie avec un chiffre au-delà de 1,50. Comme autre facteur, vous avez le diabète sucré, puis l'histoire familiale de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire une hérédité ou une prédisposition à la maladie cardiovasculaire.

Quand vous avez un père ou un frère qui présente un infarctus immunitaire de moins de 55 ans, moins de 65 ans chez une mère ou une sœur, ou un AVC ischémique moins de 45 ans chez les parents ou frères et sœurs. Alors ces facteurs de risque, on les a soumis dans un tableau. Vous avez les facteurs de risque non modifiables, à savoir l'âge, le sexe masculin et la prédisposition génétique, les facteurs de risque biochimiques ou physiologiques, à savoir l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et le diabète, et puis les habitudes de vie.

Quand vous avez une mauvaise alimentation avec une alimentation riche en graisse, saturée et calories, tabagisme, sédentarité avec une pratique d'activité physique de moins de 30 minutes, à savoir moins de 3 heures par semaine, et une obésité surtout surtout abdominale. Et ces paramètres, on va les définir dans les cours suivants. Une chose importante à vous définir, c'est la notion de risque cardiovasculaire global.

C'est le cumul des facteurs de risque chez un individu donné, et ceci on pourrait le calculer à travers des tablettes telles que ce que vous avez schématisé en bas, qui va nous calculer le risque de décès cardiovasculaire en 10 ans. Je prends l'exemple d'une femme qui n'est pas fumeuse, qui a une tension à 140 et qui a une cholestérol totale à 8, donc elle a 3%, c'est-à-dire elle est située dans la zone, si l'on veut dire, faible à intermédiaire pour avoir un risque de décès en 10 ans. Cette notion de risque cardiovasculaire est intéressante dans la mesure où vous stratifiez votre patient, et puis vous aurez des cibles thérapeutiques qui seraient particulières en fonction de chaque niveau de risque cardiovasculaire.

Alors on avait fini avec les facteurs de risque, donc on passe aux antécédents. Sur le plan personnel, c'est l'ensemble de l'affection qu'a présenté le patient antérieurement, que ce soit cardiaque ou pas, des façons liées directes apparentes, des possibles incidents sur le diagnostic ou le traitement qu'on peut instaurer, donc je vous donne des exemples. Quelqu'un qui a une pathologie pulmonaire chronique dans ses antécédents, à savoir une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui va engendrer une hypertension pulmonaire, cette hypertension pulmonaire qui est la post-charge du VD qui va être élevée, donc ça va retortir sur le cœur d'or par une hypertrophie d'hypertrophie du cœur d'or, d'accord? Quelqu'un qui est asthmatique, on aurait une contre-indication d'un traitement qui est majoritaire en cardiologie qui est le goutte à bouquins, la présence d'un rhumatisme articulaire aigu dans l'enfance et des engelures fréquentes prédisposent à avoir une valvulopathie et puis une hyperthyroïdie peut aussi être à l'origine de troubles du rythme cardiaque.

Alors, autre chose à préciser, si le patient prend d'autres traitements, leur posologie, la date de début et le fin. Sur le plan familial, vous recherchez donc une prédisposition génétique et les facteurs de risque cardio-vasculaire familiaux. Alors, après avoir fini avec tout ceci, on rentre dans l'histoire de la maladie.

Cette histoire de la maladie va tirer son origine à partir de la plainte ou du motif de consultation et vous avez pratiquement 4 signes cardinaux, dyspnée, douleur thoracique, malaise, perte de

connaissance et palpitations, je vous remercie.